Urétéroscopie dans le traitement des calculs du haut appareil urinaire dans deux hôpitaux universitaires du Burkina Faso: résultats préliminaires

Nom du présentateur : PARE Abdoul-Karim

Auteurs et coauteurs : Yé D, Kitio GJ, Simporé M, Bako A, Ouédraogo I, Ouédraogo D, Yaméogo CMD, Kirakoya B, Ouattara A, Kaboré AF

Affiliations : Service d'Urologie, CHUSS de Bobo-Dioulasso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Au Burkina Faso, la pathologie lithiasique: 12,52% des consultations en urologie
- 70% de ces calculs localisés au niveau du haut appareil urinaire (Kabore et al,2013)
- Urétéroscopie: procédé mini invasif de pratique courante en endo-urologie

Introduction

- Moyen efficace et fiable dans le traitement de la lithiase urétérale avec une morbidité moindre
- Taux de succès de 85,7% au Sénégal (Niang et al, 2016) et 95,2% au Mali (Cissé et al, 2020).
- Pratique nouvelle au Burkina Faso

Objectif

Rapporter la pratique de l'urétéroscopie semi-rigide (URS S-R) dans la prise en charge des lithiases du haut appareil urinaire au CHUSS et CHUYO

Matériel et méthode(s)

- Etude rétrospective descriptive sur une période de 10 mois (janvier - octobre 2023)
- Services d'Urologie du CHUSS de Bobo Dioulasso et du CHUYO de Ouagadougou
- Echantillon: patients hospitalisés pour lithiase du HAU et prise en charge par Urétéroscopie laser ou lithoclast

Matériel et méthode(s)

Colonne de vidéo endoscopie + matériel de fragmentation

1 écran HD

2 processeur vidéo

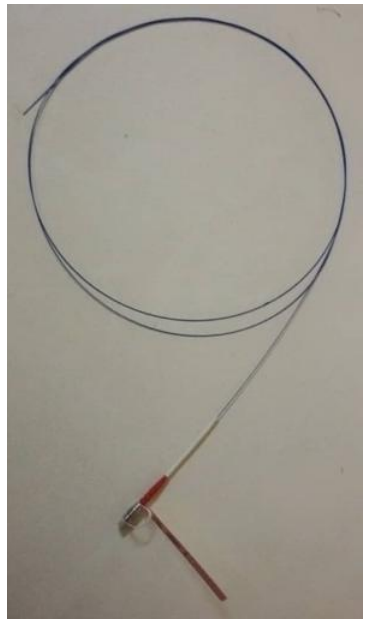
3 lithoclast

4 source de lumière froide

5 générateur pour l'électrochirurgie

6 générateur laser Storz Calculase II

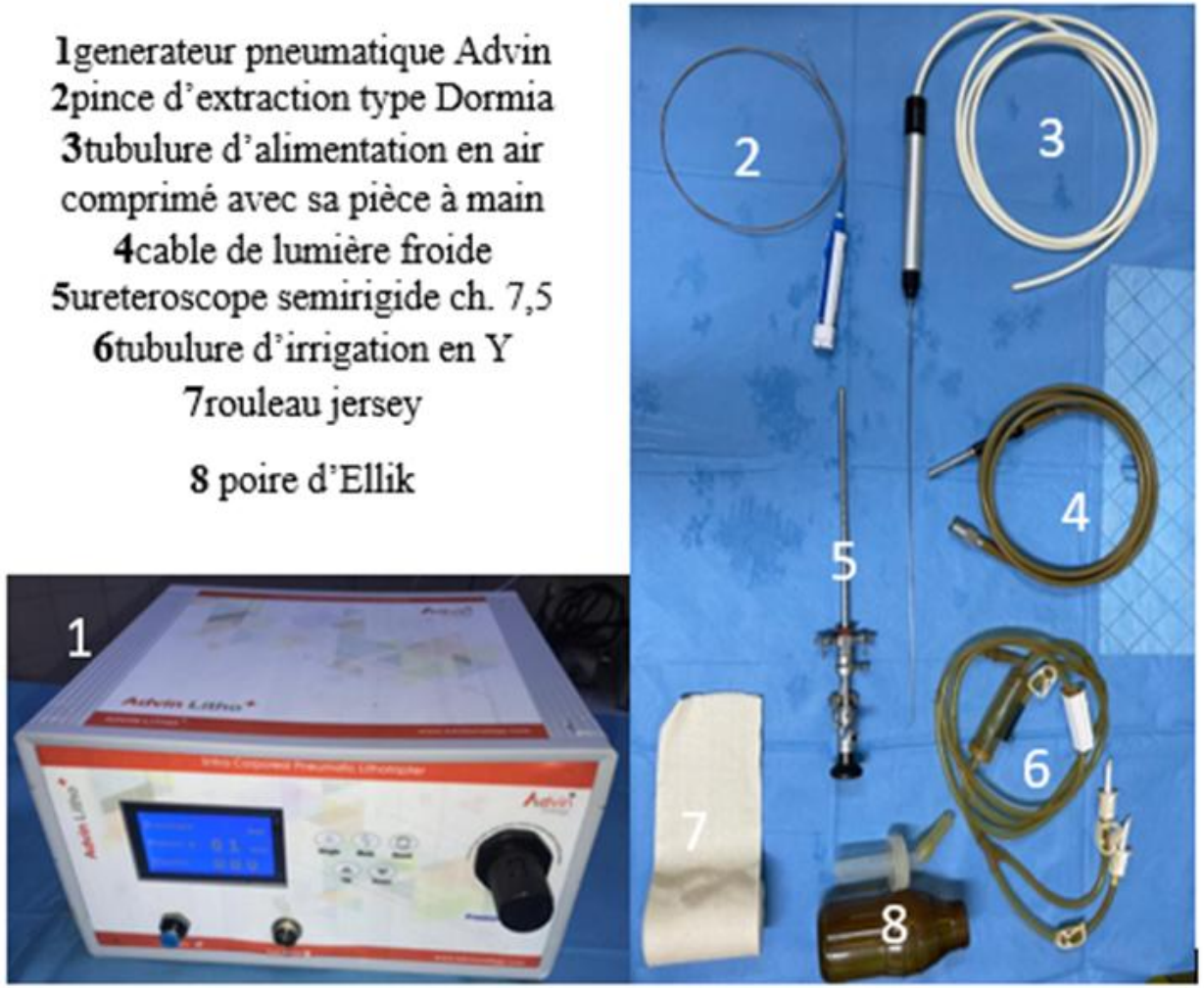
Matériel et méthode(s)



générateur de laser (Storz Calculase II) avec une fibre laser

1generateur pneumatique Advin
2pince d'extraction type Dormia
3tubulure d'alimentation en air comprimé avec sa pièce à main
4cable de lumière froide
5ureteroscope semirigide ch. 7,5
6tubulure d'irrigation en Y
7rouleau jersey

8 poire d'Ellik



Résultats

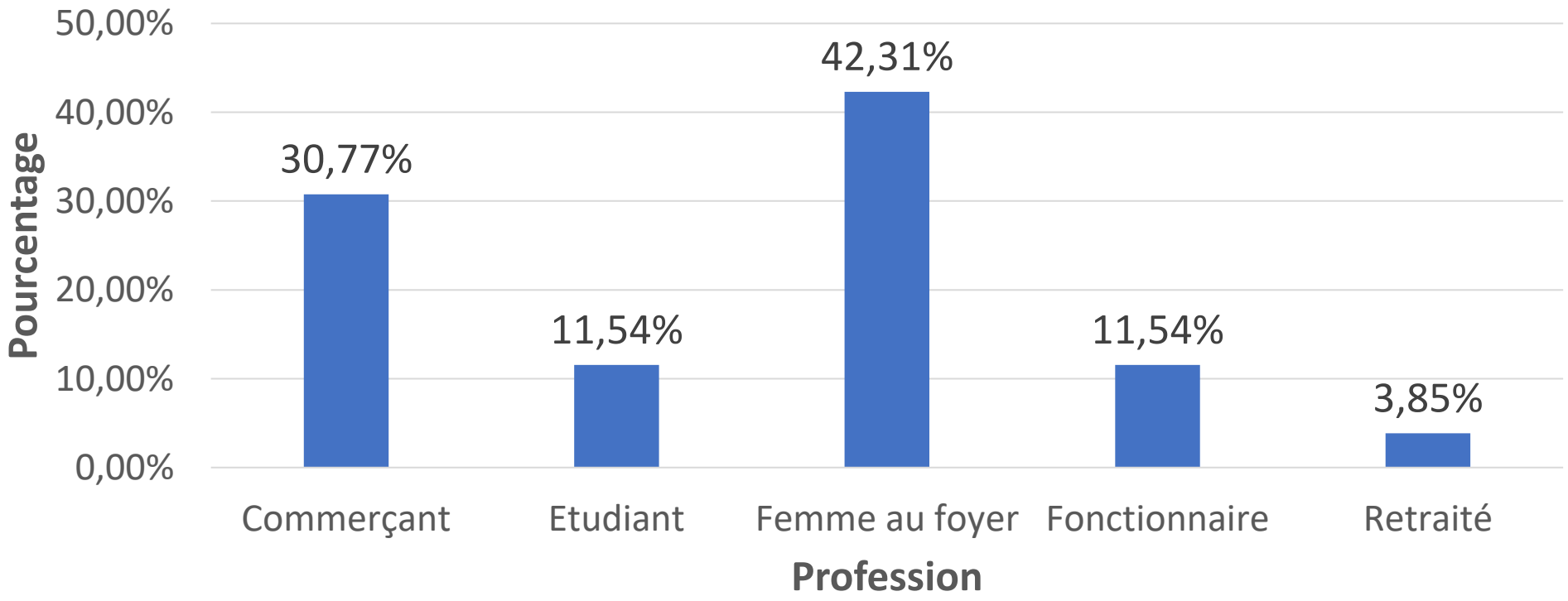
❑ Aspects épidémiologiques

- Fréquence hospitalière: 49,05% (26 URS/ 53 patients)
- Age moyen: 39,65 ans
- Tranche d'âge : [21 -30 ans]
- Sex ratio : 1

Tranche d'âge (année)	Fréquence (N)	Pourcentage (%)
21-30	10	38,46
31-40	5	19,23
41-50	5	19,23
51-60	3	11,54
61-70	3	11,54
Total	**26**	**100**

Résultats

❑ Aspects épidémiologiques



Résultats

❑Aspects cliniques

- **Délai moyen de consultation** : 12 mois [6 et 26 mois]
- **Motif de consultation**
  - Colique néphrétique : 57 %
  - Douleur lombaire intermittente : 43 %

Résultats

❑Aspects cliniques

- Etat général conservé
- Sensibilité fosse lombaire : 76,92%
- Douleur point urétéral moyen : 30,76%

Résultats

❑ Aspects paracliniques

▪Biologie

ECBU : leucocyturie (19,23 %), germe isolé dans (23 %)

E. coli (4 patients), K. pneumoniae, Candida albicans

Résultats

❑ Aspects paracliniques

▪Imagerie

TDM : latéralité droite dans 61,54% (n=16) et 38,46% (n=10) à gauche

Topographie pelvienne 69,23% (n=18) et lombaire dans 30,77% (n=8)

Taille moyenne du calcul = 13,73mm (7-22)

Résultats

❑ Aspects paracliniques

▪**Densité moyenne calcul :** 964,57 UH [457 UH et 1522 UH]

Densité calcul (UH)	Fréquence (N)	Pourcentage (%)
≤500	2	14,29
501-750	3	21,43
751-1000	2	14,29
1001-1250	3	21,43
≥1250	4	28,57
Total	**14**	**100**

Résultats

❑ Aspects thérapeutiques

▪**Durée moyenne fragmentation :** 97min [55-145min]

Durée (min)	Fréquence (N)	Pourcentage (%)
≤60	1	3,84
61-120	19	73,08
>120	6	23,08
Total	**26**	**100**

Résultats

❑ Aspects thérapeutiques

- Fragmentation du calcul par le Laser : 53,85%
- Fragmentation du calcul par le Lithoclast : 46,15 %
- Tous les patients : pose de sonde urétérale double J

Résultats

❑ Aspects thérapeutiques

- Suites opératoires simples
- Durée moyenne de drainage : 15,6 jours [10- 35 jours]
- Durée moyenne d'hospitalisation : 2 jours [10- 35 jours]
- Evolution clinique favorable : M1 et M3

Conclusion

- URS-SR relativement récente au Burkina Faso
- URS-SR Laser et balistique : technique fiable, sure, efficace et reproductible entre les mains expérimentées
- Traitement de choix des calculs du haut appareil urinaire
- Défi : maitrise de la technique par l'urologue, l'acquisition et la maintenance de l'arsenal technique

Merci pour votre attention